

DIP · doença inflamatória pélvica

DIP é infecção do trato genital superior (endometrite, salpingite, abscesso tubo-ovariano). Diagnóstico é clínico; limiar baixo para tratar reduz sequelas (infertilidade, EEU, dor crônica).

Critérios mínimos (CDC/ideia de prova)

- Dor em baixo ventre em mulher sexualmente ativa +
- Dor à mobilização do colo OU dor anexial OU dor uterina à palpação
- Apoio: febre, leucorreia mucopurulenta, PCR/VHS !, diplococos/Gonococo/Clamídia

Indicações de internação

Critério | Motivo

Abscesso tubo-ovariano | Risco de ruptura / necessidade EV

Gestação | Esquema e vigilância hospitalar

Náusea/vômitos / intolerância VO | Falha de via oral

Sinais de sepse / dúvida diagnóstica | Cirurgia / observação

Falha do tratamento ambulatorial | Reescalonar ATB

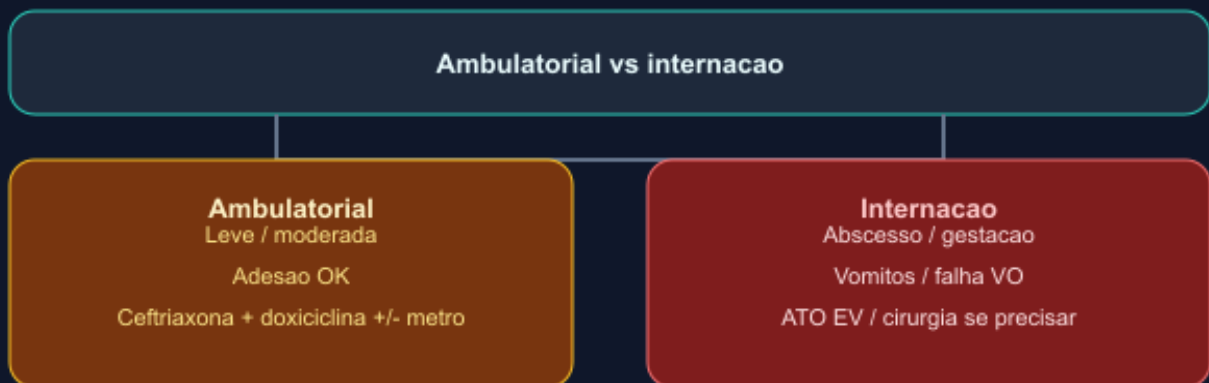
Parceiro e IST

Dica - Parceiro e IST

Trate parceiros, oriente abstinência até cura e teste outras IST (HIV, sífilis, hepatites conforme protocolo).

Escolha o cenário pelo critério de gravidade e capacidade de adesão.

DIP - local de tratamento



Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Atraso no tratamento aumenta infertilidade tubária e gravidez ectópica. Com critérios mínimos, trate empiricamente — não espere 'cultura positiva'.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Doença inflamatória pélvica: critérios CDC mínimos + critérios adicionais/específicos fecham diagnóstico e urgência.

DIP - criterios CDC

Minimos + adicionais + especificos

- 1 MIN: dor a mobilizacao cervical
- 2 MIN: dor a palpacao uterina
- 3 MIN: dor a palpacao anexial
- 4 ADD: febre > 38,3 C
- 5 ADD: leucocitose / PCR-VHS altas
- 6 ADD: mucopus cervical / IST+
- 7 ESP: abscesso / histologia / laparoscopia

Tratar empiricamente se minimos + risco

Camadas diagnósticas CDC

Nível | Conteúdo | Uso

Mínimos | Dor à mobilização cervical e/ou útero e/ou anexos | Iniciar tratamento empírico se sexualmente ativa + dor pélvica

Adicionais | Febre, mucopus, leucocitose, PCR/VHS, IST+ | Aumentam probabilidade

Específicos | Abscesso no US/TC, histologia, laparoscopia | Confirmam; nem sempre disponíveis

Armadilha

Atencao - Armadilha

Não espere cultura/imagem para tratar se critérios mínimos + contexto. Atraso aumenta risco de abscesso, infertilidade e GEU.

Internação clássica

- Abscesso tubo-ovariano, peritonite, sepse
- Gestação, imunodepressão, falha ambulatorial
- Náuseas/vômitos que impedem VO; dúvida diagnóstica importante

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1